



Diário Clínico

Consulta Externa

18-Set-2025 Dr(a). Rui Valente (HUC-UROLOGIA)

71A, vigilância Ca próstata pós-prostatectomia radical 2022. AP: adenocarcinoma próstata sob bloqueio hormonal, DM2, HTA, DPOC moderada; ex-fumador. Sem intercorrências urológicas desde última observação.

Assintomático. Sem hematúria macroscópica, disúria, polaquiúria, urgência ou dor pélvica/perineal. Continência mantida, sem necessidade de pensos. Noctúria ocasional 1x/noite, antiga, sem agravamento e sem impacto funcional relevante. Sem febre, lombalgia, dor óssea, perda ponderal ou queixas constitucionais. Mantém disfunção erétil, previsível no contexto pós-cirúrgico e de privação androgénica; sem desejo de terapêutica dirigida nesta fase.

MH: bicalutamida 50 mg id, mantida; restante terapêutica crónica sem alterações referidas.

EO: bom estado geral, eupneico em repouso. TA 132/74 mmHg, FC 76 bpm, SpO2 96% AA, T 36,4°C. Abdómen plano, depressível, indolor, sem massas ou globo vesical. Sem edema MMII. TR: esfíncter normotónico; loja prostática vazia, sem nodularidade, induração ou dor; ampola rectal sem sangue.

MCDTs: PSA total 18/09/2025 <0,01 ng/mL, previamente <0,01 ng/mL em 14/03/2025; sem tendência ascendente, sem critérios de recidiva bioquímica. Testosterona total em níveis de castração, 0,18 ng/mL. Creatinina 0,94 mg/dL, TFG_e 85 mL/min/1,73m². Hb 14,1 g/dL, leucócitos 7,2x10⁹/L, plaquetas 238x10⁹/L. Urina II sem hematúria, leucocitúria, nitritos ou proteinúria; glicose positiva no contexto de empagliflozina.

Ca próstata pós-PR, sob hormonoterapia, PSA indetetável. Sem evidência clínica ou bioquímica de recidiva. Manter bicalutamida 50 mg id. Sem indicação actual para abordagem farmacológica/invasiva da DE; reavaliar se alteração de preferência. PSA total e testosterona antes da próxima consulta, em 6 meses. Orientado para contacto precoce se hematúria, dor óssea persistente, sintomas urinários novos ou agravamento clínico.

04-Fev-2026 Dr(a). Luís Mendonça (HUC-PNEUMOLOGIA)

71A, ex-fumador ~40 UMA, cessação 2019. DPOC moderada; HTA, DM2, Ca próstata pós-prostatectomia sob hormonoterapia. Reavaliação pós-exacerbação tratada SU em Jan/2026. Refere melhoria progressiva desde então. Sem dispneia em repouso, sem ortopneia ou dor torácica. Dispneia apenas para esforços moderados, semelhante basal. Tosse produtiva residual, expectoração mucóide escassa, em diminuição; sem hemoptises, febre ou arrepios. Sem nova ida ao SU, sem necessidade actual de SABA além do habitual.



Diário Clínico

Consulta Externa

MH: tiotropio 18 mcg id inal., salbutamol SOS. Refere adesão regular e técnica inalatória aparentemente adequada; revistos passos de utilização. Mantém abstinência tabágica.

EO: apirético, TA 132/74 mmHg, FC 78 bpm, SpO2 95% AA. Sem uso de musculatura acessória, discurso fluente. AP: MV globalmente diminuído, expiração discretamente prolongada; sem sibilos audíveis, sem fervores focais. Sem edemas periféricos.

Espirometria controlo: qualidade aceitável/reprodutível. CVF 3,18 L (82% previsto), VEMS 1,62 L (57% previsto), VEMS/CVF 0,51, compatível com defeito ventilatório obstrutivo moderado. Curva fluxo-volume com concavidade expiratória. Após broncodilatador, VEMS 1,68 L, variação +60 mL/+4%, sem resposta broncodilatadora significativa. Comparativamente a estudo de 03/2025, sem alteração funcional relevante; VEMS pré-BD então 1,66 L, CVF 3,22 L. Sem evidência funcional de restrição.

Revista TAC torácica prévia: parênquima com alterações enfisematosas centrolobulares ligeiras, predominando lobos superiores, sem condensações, vidro despolido ou derrame pleural. Nódulo sólido subpleural no segmento posterior LSD, 4 mm, margens regulares, mantém dimensões e morfologia face a exame anterior. Sem novos nódulos suspeitos. Sem adenopatias mediastínicas/hilares de significado patológico. Vias aéreas centrais permeáveis; sem lesão endobrônquica identificável. Mantém vigilância imagiológica programada, TAC baixa dose conforme calendário.

DPOC clinicamente em recuperação pós-exacerbação, sem critérios actuais para corticoterapia/ATB. Manter tiotropio 18 mcg id e salbutamol SOS, sem escalonamento inalatório nesta fase. Reforçada vacinação antigripal anual e antipneumocócica, confirmar actualização no CSP. Alertado para agravamento de dispneia, aumento/purulência da expectoração, febre ou hemoptises. Reavaliação Pneumologia em 6 meses, com espirometria; antecipar se intercorrência.

12-Jun-2026 Dr(a). Luís Filipe Matos (HUC-OFTALMOLOGIA)

Refere visão turva ocasional, flutuante, sobretudo para longe/fim do dia; sem dor ocular, hiperemia, metamorfopsias, diplopia ou escotomas. AV cc OD 9/10, OE 9/10. PIO 15/16 mmHg. Biomicroscopia: córnea transparente, CA formada e tranquila; cristalinos com discreta esclerose nuclear e opacidades corticais iniciais bilat., sem impacto funcional relevante. Fundo ocular sem alterações agudas. Catarata incipiente OU; sem indicação cirúrgica. Actualizar correcção óptica se necessário, vigilância anual/PRN agravamento.